



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEMASANGAN KATETER URINE PASIEN ANAK LAKI-LAKI

No. Dokumen
155/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2024

No. Revisi
00

Halaman
1 / 2

STANDART PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
06 Februari 2024

Ditetapkan Oleh :
Direktur RS. Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS

Pengertian	Memasukkan selang kateter urine ke dalam kandung kemih melalui uretra pada pasien anak laki-laki
Tujuan	Katerisasi uretra pada Anak laki-laki dilakukan untuk membantu menegakkan diagnose pada kondisi sebagai berikut: 1. Pengumpulan specimen urin yang tidak terkontaminasi sebagai bahan pemeriksaan mikroskopis 2. Umumnya dilakukan pada pasien dengan gejala infeksi saluran kemih (ISK) untuk mengetahui mikroorganisme penyebab infeksi 3. Dilakukan khusus untuk pasien yang tidak mampu buang air kecil sendiri dengan normal.
Kebijakan	Peraturan Direktur Pedoman Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 419/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 Tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien
Prosedur	1. Persiapan alat dan bahan : a. Sarung tangan steril b. Kateter urine sesuai ukuran c. Urine bag dan penggantungnya d. Spuit yang berisi cairan aquades/WI sesuai ukuran kateter e. Jeli f. Cairan antiseptik g. Sarung tangan bersih h. Kom bersih i. Wadah sampel urine, jika perlu j. Kapas/kasa dan cairan antiseptik k. Pengalas l. Bengkok m. sampiran 2. Langkah – langkah : a. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap dan tanggal lahir) b. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. c. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: d. Jaga privasi dengan memasang sampiran e. Atur posisi telentang dengan kaki abduksi f. Letakkan pengalas di bawah bokong g. Tutup area pinggang dengan selimut h. Lakukan kebersihan tangan dengan 6 langkah i. Pasang sarung tangan bersih j. Bersihkan area genitalia dengan kapas/kasa dan cairan antiseptik k. Bilas dan keringkan, kemudian lepaskan sarung tangan bersih. l. Buka set kateter steril dan alat-alat steril lainnya dan tempatkan di alas steril dengan tetap mempertahankan teknik aseptik m. Pasang sarung tangan steril n. Sambungkan kateter dengan urine bag o. Pegang penis tegak lurus dengan tangan nondominan dan masukkan 10 ml jeli ke dalam meatus uretra dengan tangan dominan p. Tutup meatus uretra dengan jari telunjuk selama 1-2 menit

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMASANGAN KATETER URINE PASIEN ANAK LAKI-LAKI		
	No. Dokumen 155/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2024	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	q. Masukkan kateter ke dalam meatus uretra secara perlahan dengan tangan dominan sampai sampai pangkal kateter sambil menganjurkan traik napas dalam r. Lakukan fiksasi internal dengan memasukkan aquades/WI sesuai ukuran kateter anak untuk mengembangkan balon kateter s. Tarik kateter perlahan sampai terasa ada tahanan untuk memastikan terfiksasi dengan baik dalam kandung kemih t. Lepaskan sarung tangan steril u. Lakukan fiksasi eksternal dengan plester di area abdomen bawah dengan penis mengarah ke dada v. Gantungkan urine bag dengan posisi lebih rendah dari pasien w. Pasang sarung tangan bersih dan ambil sampel urine segera dari urine bag, jika perlu x. lepaskan sarung tangan bersih y. rapihkan pasien dan alat yang sudah digunakan z. lakukan kebersihan tangan 6 langkah ā. dokumentasikan prosedur yang dilakukan (warna urine, jumlah urine, yang keluar, jumlah aquades/WI untuk mengembangkan balon, tanggal/waktu dipasang) dan respons pasien		
Unit Terkait	Instalasi Rawat Inap (IRNA) Instalasi Rawat Jalan (IRJA) Intensive Care Unit (ICU) Instalasi Gawat darurat (IGD) Instalasi Kamar Operasi (IKO)		